

SCANNER & IRM OCCITANIE

Centre d'Imagerie Médicale
25 avenue Jean Moulin
34000 MONTPELLIER
Résultats : imagerie-occitanie.fr
Téléphone : 04.67.00.00.00

Nom : DURAND
Prénom : Camille
Date de naissance : 14/02/1992
Sexe : F

Montpellier, le 10/04/2026

Dr Sophie LACOSTE
Médecin radiologue

SCANNER THORACO-ABDOMINO-PELVIER

Indication :

Altération de l'état général avec amaigrissement récent, douleurs de l'hypochondre droit et bilan d'extension dans un contexte de suspicion de pathologie tumorale digestive.

Technique :

Acquisition volumique thoraco-abdomino-pelvienne réalisée après injection intraveineuse de produit de contraste iodé, avec acquisitions aux temps artériel et portal.
Reconstructions multiplanaires dans les plans axial, sagittal et coronal.
Analyse en fenêtres parenchymateuse, médiastinale et osseuse.

Résultats :

À l'étage thoracique :

Parenchyme pulmonaire sans foyer de condensation ni nodule suspect.
Pas d'épanchement pleural.
Pas d'adénopathie médiastinale significative.

À l'étage abdomino-pelvien :

Foie :

Foie augmenté de volume, de contours réguliers.
Présence de multiples lésions hypodenses disséminées dans les deux lobes hépatiques, la plus volumineuse mesurant 42 mm au segment VIII.
Ces lésions présentent un rehaussement périphérique au temps artériel avec un aspect en

“cible” au temps portal.

Aspect évocateur de lésions secondaires hépatiques.

Voies biliaires et vésicule biliaire :

Voies biliaires non dilatées.

Vésicule biliaire fine, sans anomalie.

Pancréas :

Pancréas de morphologie globale conservée.

Discret épaissement focal de la tête pancréatique avec atténuation hétérogène, mesurant environ 28 mm, suspect de lésion tumorale primitive.

Rate :

Rate de taille normale, homogène.

Reins et voies urinaires :

Reins de morphologie normale.

Pas de lésion suspecte ni de dilatation des cavités.

Tube digestif :

Pas d'épaississement pariétal colique suspect en dehors des limites de l'examen.

Aires ganglionnaires :

Présence d'adénopathies coelio-mésentériques et rétro-pancréatiques, la plus volumineuse mesurant 15 mm de petit axe.

Cavité péritonéale :

Absence d'épanchement péritonéal significatif.

Pas d'argument pour carcinose péritonéale visible.

Structures osseuses :

Pas de lésion osseuse suspecte.

Conclusion :

Multiples lésions hépatiques évocatrices de **métastases hépatiques**.

Présence d'une lésion suspecte de la tête du pancréas, pouvant correspondre au **site tumoral primitif**.

Adénopathies loco-régionales associées.

Ensemble évocateur d'une **pathologie tumorale pancréatique avec extension hépatique métastatique**.

Recommandations :

Bilan complémentaire recommandé :

- IRM hépatique pour meilleure caractérisation des lésions,
- TEP-TDM pour bilan d'extension,
- discussion en RCP.

Confirmation histologique nécessaire (biopsie hépatique ou pancréatique selon accessibilité).